

4 - Les angines aiguës - Pr. Raji

(0:00 - 0:55)

C'est un cours que vous aurez peut-être pu étudier quatrièmement, je crois, en maladies infectieuses. L'objectif de ce cours, c'est définir une angine éduque, différencier les différentes formes anatomiques cliniques d'angines rétémateuses, rétématoputacées, vésiculeuses, ulcéreuses et pseudomembraneuses, savoir quel est le bilan clinique et paraclinique qui permettent d'orienter le diagnostic vers une étiologie virale ou streptopoxique devant une angine rétémateuse ou rétématoputacée, parce qu'en fait c'est ça la grande problématique qui est posée sur le plan pratique. Préciser l'application de complications loco-régionales des angines.

(0:56 - 1:17)

Traiter les angines, une angine éduque, rétémateuse ou rétématoputacée d'origine streptococcine. Qu'est-ce qu'il faut donner comme traitement ? Connaître les indications des amnégalectomies. En général, les angines en répétition amènent à une amnégalectomie, donc il faut savoir quelles sont les indications.

(1:17 - 1:48)

Savoir orienter le diagnostic vers une étiologie devant une angine vésiculeuse, devant une angine ulcéreuse, et bien entendu savoir différencier une angine ulcéreuse d'un cancer de l'amygdale. Ça c'est important, parce que l'angine ulcéreuse et le cancer de l'amygdale sont deux choses totalement différentes. L'une répond à des traitements antibiotiques, l'autre c'est vraiment la chirurgie, la radiothérapie, la chirurgie en fonction.

(1:50 - 2:23)

Les signes en faveur du mononucléose infectieuse devant certainement l'angine pseudomembraneuse et bien sûr prêter l'angine mononucléosique. Alors c'est quoi une angine ? C'est une inflammatoire aiguë de l'homopharynx, plus ou moins focalisée sur les amygdales palatines. Et vous savez très bien que nous avons comme amygdale, pas seulement les amygdales palatines, parce que nous avons quoi d'autre que l'amygdale ? Par un G, elle a un noyau.

(2:23 - 2:58)

Elle forme ce qu'on appelle la noyau de baldaïère et elle se trouve vraiment à l'entrée de la cavité de l'homopharynx et du rhinopharynx. L'homopharynx est bien entendu permettant de prendre en charge tous les virus et bactéries qui vont entrer au niveau de notre organisme. C'est une pathologie qui est très fréquente et pourquoi est-ce qu'on ne vous enseigne pas ? Parce qu'un germe qui est des germes les plus fréquemment intéfais dans cette pathologie, c'est le

streptococcus beta-hémolytica.

(2:59 - 3:35)

Le streptococcus beta-hémolytica est responsable de complications et bien sûr, dont le traitement est purement médical. Sur le plan anatomique, l'oropharynx, vous le connaissez, c'est une région anatomique qui vient à la jonction du rhinopharynx supérieur et de l'hypopharynx inférieur et qui est limitée par ce qu'on appelle l'isthme du gosier, avec bien entendu les piliers postérieurs du voile du palais, les piliers antérieurs du voile du palais. Entre les deux, on retrouve la loge amygdale.

(3:36 - 4:03)

Et dans cette loge amygdale, il va y avoir l'amygdale qu'on appelle l'amygdale. Pourquoi on l'appelle l'amygdale palatine ? C'est parce qu'elle existe entre les deux piliers du voile palatine du palais. Et bien entendu, à ce moment-là, elle peut aussi être le siège d'un certain nombre de pathologies, plus particulièrement les infections, en l'occurrence les angines.

(4:04 - 4:53)

C'est une pathologie à fréquence très élevée, vous le comprenez très bien, c'est une voie à l'accès rapide des germes, plus particulièrement chez l'enfant, et sans aucune prédominance de sexe. La bactériologie ou l'épidémiologie de cette pathologie est répartie entre les virus et les bactéries. Au niveau des virus, vous voyez la liste, les adénovirus, les virus influenzés, les parainfluenzés, les virus respiratoires, le cytomégalovirus, le virus d'Epstein-Barr, l'herpès simplex, l'herpesvirus Coxsackie, ce sont des virus qui peuvent être responsables des angines, et bien entendu, d'autres bactéries qui peuvent être responsables, en particulier des streptococcus bêta-hémolytiques.

(4:54 - 6:23)

Mais vous pouvez avoir aussi les Fusobacterium, les Clostridium Vincentii, les Corynebacterium, le pneumococcus, le staphylococcus, le chlamydiaire, les mycoplasmes, et les Haemophilus. Donc vous avez une panoplie de germes qui sont responsables, et donc vous aurez l'impression de dire « est-ce que du fait que nous avons tellement de virus et tellement de bactéries, on ne s'entraînerait pas à faire éventuellement ? » C'est sur le plan pratique très compliqué, vu le délai du diagnostic bactériologique, et comparé à la prise en charge. Sur le plan clinique, on répartit ce groupe en différentes catégories en fonction du tableau anatomique, à savoir les angines érythémateuses et érythématopultacées, érythémateuses, c'est-à-dire les angines rouges, érythématopultacées, c'est-à-dire les angines rouges accompagnées de tâches blanc-châtres, les angines béruculeuses avec des bérucules, les ulcéreuses avec des ulcérations, et les pseudomembraneuses, où l'amygdale est couverte de membranes, on les appelle pseudomembraneuses parce que ça risque de venir, on peut les détacher ou pas les détacher en

fonction de la situation, on va bien sûr le voir.

(6:24 - 6:53)

Alors sur le plan fonctionnel, ce sont des patients dans le cadre de l'ongine erythématopultacée qui vont venir consulter pour des douleurs par un G accentué à la députation. Et donc en fait, c'est une douleur par un G à la députation. On avale combien de fois par jour ? Tout le temps.

(6:54 - 7:13)

Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'avaler tout le temps ? À cause de l'esprit. Donc on avale tout le temps, ça veut dire que celui qui a mal au niveau de la région italienne, il va dire j'ai mal. C'est quand vraiment vous lui posez la question, mais à quel moment vous avez trop mal ? C'est au cours de la députation.

(7:13 - 7:39)

Pourquoi au cours de la députation ? Parce que ça fait mobiliser le voile, ça fait mobiliser la base de langue, retoucher les amygdales et ça fait mal. D'accord ? Alors, avec ce symptôme principal, vous avez une autalgie réflexe. Ça veut dire quoi, autalgie réflexe ? Donc c'est une douleur à l'oreille, avec une oreille normale.

(7:40 - 7:54)

Point. Et avec de la fièvre. Et donc dans le diagnostic, c'est facile, si quelqu'un a mal au niveau par un G et c'est accentué à la députation et qui fait de la fièvre, c'est une angine.

(7:54 - 8:09)

Jusqu'à preuve du pancréas. On peut avoir des frissons, une asthémie, voire même des nausées. Mais le tableau clinique peut se limiter à des douleurs pharyngées accentuées à la députation, fébriles, avec de la fièvre.

(8:11 - 8:41)

Quand on examine l'oro pharynx, qu'est-ce qu'on trouve ? On peut trouver une angine, des amygdales palatines rouges, c'est ce que vous voyez là, augmenté de volume, c'est normal, vous voyez là, ils sont presque, ils se touchent. Avec ou sans un enduit blanchâtre décollable. On peut avoir une amygdale rouge, hypertrophiée de volume, et augmentée de volume, avec un enduit blanchâtre.

(8:42 - 8:50)

Mais cet enduit blanchâtre, on peut le décoller. Et même le patient peut le décoller. Et puis il l'enlève.

(8:51 - 9:20)

Et, cette amygdale palatine rouge, ou rouge cultacé, s'accompagne souvent d'une inflammation de tout l'oro pharynx. Vous voyez l'inflammation qui déborde, parfois, au niveau du voile du palais, ici non, et vous voyez là, avec un certain nombre de points qui rappellent les pétéchies. C'est ce qu'on appelle les lésions pétéchiales sur le voile du palais.

(9:22 - 9:50)

Et souvent, dans le cadre de ces angines érythémateuses ou érythématopultacées, ils sont bilatérales. Une angine érythémateuse ou érythématopultacée n'est pas unilatérale. Lorsque le germe pénètre à l'intérieur de l'oro pharynx, il ne va pas choisir l'amygdale à contaminer, il va contaminer les deux amygdales.

(9:52 - 10:46)

Donc, amygdale palatine rouge augmentée de volume avec un ongule blanchâtre décollage et donc, par conséquent, érythémateuse ou érythématopultacée avec une inflammation de l'oro pharynx, une atteinte bilatérale et bien sûr des lésions pétéchiales sur le voile. L'examen physique peut retrouver aussi des amygdalopathies pertes et sensibles sous-bigastriques, ça veut dire jugulos carotidiennes hautes et à l'examen clinique, il faut rechercher l'existence d'une splénomégalie. Une splénomégalie, c'est quoi ? C'est l'augmentation de la taille de l'araque.

(10:46 - 11:35)

Comment est-ce qu'on examine l'araque ? Le malade est dans quelle position ? C'est pas grave, parce qu'il faut savoir examiner l'araque. Il peut être très augmenté de volume et l'examen est facile, il peut être augmenté un petit peu de volume et l'examen n'est pas facile. Il faut savoir comment examiner un patient parce que l'araque normale n'est pas palpable, donc si elle est palpable, elle est anormale.

(11:36 - 12:00)

Donc la splénomégalie, associée à une angine érythémateuse ou érythématopultacée, nous fait évoquer quelle diagnostic ? La mononucléose infectieuse. Et bien sûr, si j'ai une angine érythémateuse ou érythématopultacée, je cherche systématiquement des complications. On va les voir.

(12:02 - 12:41)

MNI, angine plus splénomégalie, MNI mononucléose infectieuse. Alors, quelle est la paraclinique ? Alors, on serait tenté à faire des prélèvements de la gorge, puisque vu le nombre important de virus responsables des angines et des bactéries responsables des angines, mais il faut savoir que ce prélèvement de gorge est rarement effectué en pratique courante. Pourquoi ? Parce que

le résultat d'un prélèvement de gorge ne peut contribuer que si il me permet le diagnostic tout de suite, parce que je dois traiter.

(12:42 - 12:55)

Sinon, je suis obligé d'attendre la culture qui peut devenir, en tout cas depuis les 72 heures. Donc, en pratique, il n'est pas très utilisé. La numération formule sanguine montre une hyperleucocytose.

(12:55 - 13:46)

Si elle montre une hyperleucocytose, il l'oriente vers une biologie bactérienne. Et bien entendu, si on dispose du test de diagnostic rapide, je pense qu'on vous en a déjà parlé, ce test de diagnostic rapide va consister à prélever avec un épouvillon stérile l'enduit au niveau de la mygdale qu'on va mettre à l'intérieur d'une solution qui est livrée dans le box du test et on le laisse une minute. Après une minute, bien sûr, les germes que nous avons prélevés existent à l'intérieur de ce liquide et on va mettre une bandelette réactive qui contient les anticorps contre le streptococcus.

(13:47 - 14:15)

Et à ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle les bandelettes réactives. À ce moment-là, on va avoir plusieurs résultats. Soit le test est positif, vous voyez là, soit le test est négatif et donc s'il est positif, ça veut dire que l'enduit est streptococcique, soit qu'il est négatif et donc il n'est pas streptococcique, soit que je ne peux pas prendre de décision parce que même le contrôle n'est pas positif.

(14:16 - 15:04)

Et à ce moment-là, je vais savoir à quel moment je dois utiliser l'antibiotique, à quel moment je ne dois pas utiliser l'antibiotique et bien entendu, dans le cas où je vais considérer soit que je refais l'examen, soit que éventuellement je considère que c'est très probablement streptococcique. Donc vous comprenez un peu quelle est l'importance de ces tests de diagnostic rapide qui, bien entendu, a une sensibilité de 90% et une spécificité de 95%. Ça veut dire qu'il va me permettre de pouvoir dire l'angine que j'ai chez ce patient est une angine streptococcique et par conséquent je suis obligé d'utiliser des antibiotiques.

(15:05 - 15:58)

Alors pourquoi ce test de diagnostic rapide est important ? C'est parce qu'il me permet de ne pas utiliser des antibiotiques quand il ne les faut pas et de ne pas réaliser des dépenses inutiles en termes d'économicacité et bien entendu si j'utilise les antibiotiques à bord et à travers, qu'est-ce que je risque de développer des risques ? Mais malheureusement, ce test n'est pas encore réalisé de façon systématique au Maroc. Je pense que ça va venir dans les quelques années et

ça va nous permettre de pouvoir sélectionner quel patient est traité par l'antibiotique et quel patient n'est pas traité par l'antibiotique. Alors quelle est l'évolution de ces angines ? L'évolution est souvent favorable.

(16:02 - 17:06)

Est-ce que vous savez comment est traitée l'angine il y a longtemps ? Pas sur le plan médical, par la médecine traditionnelle parce qu'il n'y a pas que la médecine que vous étudiez. Il y a la médecine que vous étudiez et il y a la médecine traditionnelle. Vous ne savez pas ? Alors c'est ça ce qui a fait à ce que malheureusement au Maroc, le rhumatisme articulaire élevé était très fréquent.

Vous connaissez le rhumatisme articulaire élevé ? Avec les valvulopathies et tout ça, c'était très fréquent. Pourquoi ? Parce que les gens peut-être n'avaient pas accès à la médecine peut-être, ou bien ils avaient accès à la médecine mais ils utilisaient la médecine traditionnelle et ce qu'ils utilisaient c'est la graisse de poulet. Ils mettaient à ce niveau-là au niveau des ganglions et ils traitaient l'angine.

(17:07 - 17:30)

Et pourquoi ça marchait ? C'est parce que même quand on ne la traite pas l'angine guérit. Parce que les anticorps développés par le corps vont tuer le streptocoque. Mais malheureusement, ils vont tuer le streptocoque et ils vont aller aussi détruire les articulations et détruire les valvules du cœur.

(17:31 - 17:46)

Et c'est pour ça que le traitement doit être efficace. C'est pour arrêter à ce que les anticorps soient fabriqués parce qu'ils risquent de détruire les valves cardiaques. Complication immédiate, c'est le phlégon périamyctalien.

(17:46 - 18:55)

Ça veut dire une connexion pérulante qui siège entre la mygdale et la paroi musculaire de l'oropharynx. D'accord ? Il donne un tableau clinique d'angine mais avec une altération d'état général, une fièvre importante et une triade symptomatique. C'est quelqu'un qui vous dit j'avais une douleur pharyngée fébrile il y a quelques jours.

Souvent il n'a pas pris d'antibiotiques ou par malheur il a pris des anti-inflammatoires non stéroïdiens sans antibiotiques. C'est une catastrophe. Et à ce moment-là, il se voit avoir un trismus.

C'est quoi un trismus ? C'est une difficulté d'ouverture buccale. Pourquoi ? Parce que l'inflammation a touché des muscles pharyngés et bien entendu des muscles pterygoïdiens qui

sont responsables de mouvements mandibulaires. Un œdème de l'aluète et une vossure du pilier antérieur de la mygdale.

C'est ce que vous voyez là. C'est le voile du palais. Là c'est les dents.

(18:55 - 19:09)

Ici on a poussé vraiment pour couvrir la bouche et vous voyez, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la salive. Donc le patient n'arrive plus à avaler. Il a un trismus.

(19:11 - 19:23)

Il n'est plus capable de s'entendre. C'est ce qu'on appelle le trismus de la mygdale. Et un autre trismus c'est le trismus du palais.

(19:24 - 19:47)

Le trismus du palais, on l'appelle C'est à dire qu'on a un trismus qui est en très peu de place. Donc le jeune enfant, comme chez l'adulte, il a des adénopathies rétrofaringées et ces adénopathies rétrofaringées peuvent s'abséder et donner une collection rétrofaringée qui peut obstruer l'hypopharynx. Et s'il obstrue l'hypopharynx, ça risque d'entraîner l'asphyxie.

(19:48 - 20:14)

Ce sont des complications d'angina. Et puis bien sûr, les secondaires, c'est ce que vous avez déjà étudié, c'est le RAA, c'est-à-dire le Rhumatisme Articulaire Aiguë, et la GNA, c'est-à-dire la Glomerulodifrite Aiguë, d'origine streptopoxique. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je traite une angina érythémateuse et érythématopultacée de façon efficace, j'évite aux patients tout ça.

(20:16 - 20:47)

D'accord ? Sinon, le patient risque de me faire des gros problèmes que j'aurais à traiter d'une façon parfois très coûteuse. Quelqu'un qui fait une valvulopathie, ça coûte très cher. Alors quel est le traitement ? Du moment qu'on n'a pas le test de diagnostic rapide, il faut savoir qu'actuellement, on considère une angina érythémateuse et érythématopultacée comme angine streptopoxique.

(20:48 - 21:29)

Et donc si je considère toute angine érythémateuse ou érythématopultacée comme angine streptopoxique, je suis censé utiliser des antibiotiques. Il faut savoir que le streptococque est un germe très sensible aux antibiotiques, plus particulièrement aux pénicillines. Il y a les pénicillines orales, ce que vous connaissez sous le nom de pénicilline V, qui sont des maladies compliquées.

(21:29 - 21:39)

On les utilise pour les maladies compliquées. On les utilise pour les maladies compliquées. Donc les maladies compliquées sont les pénicillines ou les pénicillines, qui sont les maladies compliquées.

(21:39 - 40:13)

Du moment que on a la maladie d'une angine érythématopultacée, et cette amoxicilline doit être utilisée à dose efficace et pendant seulement six jours ça veut dire une durée assez courte, ça s'appelle le traitement de l'angine assez courte qui soit proche de la durée d'évolution favorable de l'angine érythémateuse ou érythémato-pupasse si bien entendu le patient a une allergie à la penicilline en face au macrolide et bien sûr on donne un traitement symptomatique parce que le malade a mal, antalgique qu'est-ce qu'on peut donner comme antalgique à un patient qui a une angine ? du paracétamol et pourquoi pas de l'acétylsalicylate ? parce que c'est un anti-inflammatoire un, deux ? non c'est un antipyrétique, vous voyez là, antalgique, antipyrétique antalgique, antipyrétique, paracétamol mais il y en a qui se disent dans leur tête on va utiliser un acétylsalicylate, c'est faux c'est faux pourquoi ? pour deux raisons un, c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien deux, qu'est-ce qu'il entraîne ? une thrombopathie il va être responsable d'hémorragie si au cas où nous sommes obligés d'opérer le patient d'accord ? parce qu'il se peut que quelqu'un chez qui on a mis des antibiotiques des antalgiques soit au conflit d'inflammation et d'inflammation et s'il se conflixe nous serons obligés d'inciser et si on incise alors qu'il est sous acétylsalicylate il va saigner il vaut mieux ne pas avoir cette situation et c'est la raison pour laquelle il faut utiliser du paracétamol antalgique antipyrétique alors quel est le traitement du fléchissement péri-amygdalien ? premièrement c'est une complication et donc toute complication nécessite quoi ? l'hospitalisation on ne traite pas les complications à la maison hospitalisation qu'est-ce qu'on fait ? regardez ça c'est un schéma on ponctionne ensuite on incise on ponctionne pourquoi ? c'est pour avoir de la bactériologie parce que maintenant il faut savoir quelle germe deuxièmement on incise en évacue parce que c'est un abcès et bien entendu on donne des antibiotiques est-ce qu'on les donne par la bouche ? non on les donne par voie parentérale par voie intraveineuse c'est la même famille d'antibiotiques et bien sûr un patient fait une complication type fléchissement péri-amygdalien au bout d'un mois de traitement on lui enlève les amygdales on ne lui donne plus la chance de refaire le fléchissement péri-amygdalien c'est pas la chance et on lui enlève les amygdales maintenant alors quelles sont les indications des amygdalotomie ? premièrement les angines à répétition qu'est-ce que ça veut dire angine à répétition ? comment ? supérieur à 4 épisodes par an savoir que la définition d'angine à répétition varie au pays au Canada c'est 7 épisodes par an ailleurs je ne sais pas chez nous c'est 4 épisodes mais vraiment la dernière année qu'est-ce que ça veut dire angine ? parce que souvent les parents vont vous dire mon enfant a fait des angines souvent par angine et donc il ne faut prendre l'épisode angine que lorsque le patient fait une dysphagie fibrile et fibrile, avec de la fièvre les amygdales instructives vous voyez, regardez si vous regardez cet oropharynx vous voyez les amygdales chez cet enfant

ils se touchent et ça veut dire quoi ? ça veut dire que cet enfant n'arrive pas à respirer ni s'alimenter normalement il faut lui enlever surtout, souvent il fait un syndrome instructif du sommeil donc il faut lui enlever les amygdales pour que son oropharynx soit assez libre pour lui faire pénétrer de l'air et bien entendu l'alimentation l'amygdalite chronique cryptique il y a un certain nombre de personnes qui ont un certain nombre de concrétions alimentaires qui se concentrent au niveau des amygdales qui sont éliminées d'eux-mêmes ils sont nauseabonds ils ont une odeur particulière ça s'appelle l'amygdalite cryptique chronique et le traitement de cette amygdalite chronique cryptique ce n'est pas les antibiotiques il faut enlever les amygdales parce qu'ils sont souvent le siège d'inflammation sans fièvre et cette inflammation retient les aliments et bien sûr en retenant les aliments ça donne des sécrétions Le fléchement périmé amygdalien on vient de le voir mais est-ce qu'il faut faire l'amygdalectomie à chaud ou à froid souvent il est préférable de la faire après le fléchement médical et bien sûr on peut discuter ça c'est quelque chose qui se discute avec les pédiatres lorsqu'on a des complications générales et qu'on n'arrive pas à gérer les angines à répétition à ce moment-là on peut réaliser une amygdale d'accord ? alors ce petit enfant, qu'est-ce qu'il a ? pourquoi il dort la bouche ouverte ? c'est parce que souvent les hypertrophies amygdaliennes s'accompagnent d'une hypertrophie des amygdales faringées des amygdales faringées des végétations et donc quand les végétations sont obstruées la respiration par le nez n'existe plus et donc les enfants sont obligés d'ouvrir la bouche pour respirer et les parents vont nous dire qu'ils renflent et parfois même leur respiration s'arrête la nuit c'est ce qu'on appelle le syndrome d'os le syndrome d'amnésie post-expiration alors les angines vésiculeuses ça c'est le deuxième chapitre les angines vésiculeuses leur symptomatologie fonctionnelle est similaire à l'angine irrégulateuse ils donnent le même tableau clinique la seule différence qui existe c'est l'examen physique et qu'est-ce qu'on trouve à l'examen physique l'oropharynx est rouge parlementaire du vésicule tout l'oropharynx est rouge aussi bien les amygdales que le voile du palais vous les voyez les petits points là qui existent sur le voile ce sont des vésicules qui peuvent siéger sur le voile la luvette voire même au niveau des piliers et cette angine vésiculeuse est souvent bilatérale et s'associe à ce qu'on appelle la gingivostomatite ça veut dire une inflammation avec des vésicules qui siègent au niveau de la gencive et toute la muqueuse buccale alors lorsque il est bilatéral avec une gingivostomatite il faut penser à l'herpès simplex virus d'accord quand elle est purement unilatérale ça veut dire que j'ai une angine vésiculeuse mais vésiculeuse en unilatérale ça ressemble à un zona c'est le zona qui donne les lésions vésiculeuses unilatérales et bien entendu lorsque ça touche les pommes des mains et les plantes des pieds et en même temps la bouche, c'est ce qu'on appelle la maladie main pied bouche, il faut penser à l'antérovirus Cocksackie alors les angines vésiculeuses vous voyez que leur étiologie sont souvent des étiologies virales le traitement est un traitement antalgique local et général et parfois, si bien sûr nous sommes dans des terrains particuliers, on peut leur associer un traitement antiviral local ou parfois général tout dépend de l'état immunitaire du patient et du tableau public avec lequel il se présente les angines ulcéreuses alors les angines ulcéreuses, on en a deux, c'est l'angine de Vincent et l'angine séphilitique alors c'est quoi l'angine de Vincent alors c'est une angine qui est due à un bacille gram-négatif c'est ce qu'on appelle le

Fusobacterium et a une spiroquette qu'on appelle le Tréponema Vincentii c'est ça qui donne le nom à l'angine Vincent, Vincentii c'est une pathologie de l'adulte jeune et de l'adolescent mais qui présente un mauvais état glucodentaire, ça veut dire des caries dentaires des chicots dentaires etc. ça veut dire que les germes ont la possibilité de se développer dans la cavité buccale et vont aller se concentrer au niveau de dynamite alors sur le plan symptomatologie fonctionnelle le patient a une douleur pharyngée peu intense, il n'a pas trop mal en unilatéral mais il présente une asthémie importante et l'examen d'un clinique va retrouver un syndrome fibril mais souvent c'est une fièvre inférieure à 38 degrés alors comment va-t-on différencier cette ulcération d'un cancer, parce que ça peut être un cancer c'est la fièvre c'est le principe j'ai quelqu'un qui a une ulcération qui n'a pas de fièvre je ne dois pas évoquer l'angine, je lui évoque un cancer plus que l'angine mais ça peut être aussi une tuberculose ça peut être beaucoup de choses sur le plan physique, qu'est-ce que je trouve ? c'est une ulcération amygdalienne souvent unilatérale et régulière couverte de fausses membranes facilement détachables mais ces fausses membranes ne dépassent pas la mygdale alors quelle est la pathologie dans laquelle les fausses membranes dépassent la mygdale c'est la diphtérie c'est important quand vous faites la diphtérie ne dépassons pas la mygdale alors lorsque vous avez une ulcération de la mygdale il faut toucher cette ulcération et bien sûr pour la toucher il faut mettre un gant pourquoi est-ce qu'il faut mettre un gant ? parce que ça peut être de la syphilis ça peut être un champ syphilitique donc pourquoi est-ce qu'il faut la toucher ? c'est pour évaluer l'induration et dans l'angine de Vincent il n'y a pas d'induration au toucher pourquoi ? parce que l'induration va exister dans quelle pathologie ? le cancer et je trouve à l'examen cervical des petites athénopathies cervicales et psilatérales alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? je vous ai dit qu'il ne faut pas faire du prélèvement dans l'angine de l'arrêt pneumatique mais ici il faut faire un prélèvement, il faut confirmer le prélèvement de gorge au niveau de l'ulcération va trouver bien sûr si vous orientez votre diagnostic chez le bactériologiste demandant je suspecte une angine de Vincent veuillez s'il vous plaît rechercher les germes responsables il va trouver une association fuso-spirulaire et bien entendu l'annumération formule sanguine qui normalement devrait trouver une permanence c'est tout à fait normal alors il faut savoir que c'est une angine qui facilement va être traitée, nous allons le voir mais il peut être pourvoyeuse de complications qui sont les abcès cervicaux les cellulites cervicales et voire même les thromboses de la veine jugulaire interne donc ça veut dire que c'est une angine fort heureusement elle est rare mais il peut engendrer des complications parfois qui peuvent être très très redoutables alors quel est le traitement ? c'est les pénicillines ou un métronide azolé pourquoi les pénicillines ou un métronide azolé ? parce qu'on vise les pénicillines les anaérobies ce sont des germes anaérobiques donc on utilise soit l'un soit l'autre et à ce moment là pendant 10 jours de traitement et bien sûr si j'ai l'angine de Vincent je vous ai dit qu'il existe un état buccodentaire défectueux, qu'est-ce que je fais ? je traite les caries dentaires de façon systématique, après la guérison sinon j'aurai la récurrence d'accord ? donc traitement musical avec un traitement de la remise en état, c'est ce qu'on appelle remise en état de la qualité buccale pour traiter les caries dentaires déchets congénitaires etc l'angine séphilitique, ce qu'on appelle le champ séphilitique il faut y penser normalement le champ

séphilithique il existe sur les organes du niveau externe, mais il peut aussi exister au niveau de la cavité buccale, parfois même au niveau de la langue ou au niveau de l'amygdale ce qui est étonnant c'est que le tableau clinique ressemble à l'angine de Vincent quelle est la caractéristique du champ séphilithique ? sur le plan douleur c'est de l'endolone, regardez douleur par un G, peu intense très peu intense donc ça veut dire que le patient il va venir parce qu'il a une petite gêne c'est pas l'angine donc endolore, mais c'est un champ qui est enduré à sa base mais l'amygdale il reste souple, parce que ici même il faut penser au champ il faut penser au cancer le champ il est enduré, mais toute l'amygdale est souple alors souvent dans ce cadre là nous n'avons pas seulement des petites adénopathies comme on a dans le cadre de l'angine de Vincent, mais ici on a de grosses adénopathies on les appelle comment ? ils ont un nom particulier les adénopathies qui accompagnent le champ séphilithique alors comment est-ce qu'on pose le diagnostic de séphilis ? c'est facile, alors soit que on va réaliser un prélèvement qui va montrer le tréponème paludium soit qu'on va faire une sérologie séphilithique et dans ce cadre là on va la traiter et on va suivre le patient dans tous les champs séphilithiques quelle que soit la localisation et bien entendu vous savez comment ça se contamine la séphilis ce sont des gens qui risquent aussi d'avoir le VIH et par conséquent il faut demander systématiquement sa sérologie VIH dans le cadre du bilan parce que il y a un risque à ce que le patient ait la même pathologie associée par quel est le traitement ? ceci vous le savez puisque vous avez étudié les champs séphilithiques c'est soit une injection soit un traitement par les pénicillines pendant 10 jours ou une injection d'extensiline parce que souvent les patients risquent de ne pas utiliser le traitement pendant 10 jours donc parfois si vous voyez qu'il risque de ne pas suivre le traitement il vaut mieux mettre un traitement aux minutes et puis aller quels sont les diagnostics différentiels ? cela il faut y penser les localisations faringées des herméopathies il faut y penser le cancer de la mygdale et l'ARD connaissez l'ARD ? C'est quelle maladie l'ARD ? le Bessette et l'ARD amygdaliens l'ARD amygdaliens de la maladie de Bessette elle est comment ? Elle est très douloureuse pourquoi elle est très douloureuse ? parce que est-ce que l'ARD de la maladie de Bessette est une ulcération ou bien une ex-ulcération ? Il faut vérifier ça. Attention, la médecine n'est pas simple, d'accord ? Et bien entendu, le tableau de la maladie de BSEP est simple.

(40:13 - 40:34)

Si quelqu'un fait un AFT amygdalien, souvent il va faire un AFT au niveau de ses organes génitaux. Il peut faire des troubles visuels, il peut faire... Beaucoup, c'est un tableau clinique. Donc il faut penser à cette maladie-là parce que... Bien, alors les angines pseudo-membraneuses.

(40:36 - 40:47)

Alors les angines pseudo-membraneuses, il y en a deux. L'angine diphtérique, je ne pense pas que vous allez la voir. Pourquoi ? Parce que tout le monde, maintenant, est vacciné.

(40:48 - 41:13)

Et l'homonymie léon infectieuse que vous allez voir. Alors l'angine diphtérique, je pense que vous l'avez étudiée aux maladies infectieuses, je la rappelle. C'est une infection qui a une période d'incubation, le 4 jours, avec un début insidieux, une discrète altération de l'état général, une fièvre qui est modérée, une dysphagie modérée et ça se voit chez des enfants qui n'ont pas reçu de vaccination anti-glycérique.

(41:13 - 41:42)

Donc ça veut dire dans la situation qui malheureusement, heureusement maintenant, n'existe pas théoriquement parce que tout le monde est vacciné. Et lorsque j'examine le pharynx, qu'est-ce que je trouve ? Un pharynx rouge de façon diffuse, recouvert d'un enduit blanchâtre, épais, brillant, adhérent à la muqueuse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est difficilement détachable.

(41:44 - 42:01)

C'est pour ça qu'on avait dit dans l'origine érythématopultacée, l'enduit blanchâtre est détachable. Avec des adénopathies volumineuses et sensibles. Et l'évolution, c'est ça ce qui faisait à ce que la diphtérie était mortelle, c'est pour ça que la vaccination se faisait.

(42:02 - 42:14)

C'est parce que les fausses membranes vont s'étendre au larynx et aux branches. C'est ce qu'on appelle le syndrome malade. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens qui avaient la diphtérie à l'antan, ça commençait par une augmentation.

(42:15 - 42:40)

Mais qu'est-ce qui se passait après ? C'est les fausses membranes qui s'étendaient en bas vers le larynx et qui obstruaient le larynx. Et lorsqu'ils obstruaient le larynx, les patients meuraient asphyxiés. C'est pour ça que si vous avez la chance, ou je sais pas, les gens qui avaient la diphtérie avaient eu une trachéotomie avant de mettre le patient sur les antibiotiques.

(42:40 - 42:52)

C'est une trachéotomie pour les sauver. C'est ce qu'on appelle le syndrome malade. Les gens qui avaient une angine diphtérique qui touchait les branches, alors ceux-là, ils meurent.

(42:53 - 43:10)

Ils ne peuvent pas rester en vie. Alors quelle est la prise en charge ? Vous savez que la diphtérie est une maladie à déclaration obligatoire, parce qu'elle se contamine rapidement. Hospitalisation et mise en quarantaine.

(43:11 - 43:23)

Prélèvement de gorge pour confirmer la diphtérie. Et mini-test parce qu'il pose le diagnostic différentiel, une énumération formule sanguine. Et le traitement peut faire appel à une sérothérapie.

(43:23 - 43:43)

Vous savez ce que c'est que la sérothérapie ? L'utilisation des anticorps contre la diphtérie directe. Ou bien une antibiotérapie basée sur la pénicilline ou si allergie, macrolide. Et bien entendu, les patients vont subir une réanimation en fonction de l'état général du malade.

(43:44 - 44:05)

C'est-à-dire que si le malade a un état qui n'est pas très agréé, il se gère. Si le malade est très, très mal au point à ce moment-là, c'est une tracheotomie avec une respiration artificielle, etc. D'accord ? Heureusement pour vous, vous ne risquez pas de voir cette angine.

(44:05 - 44:18)

Par contre, la mononucléose infectieuse, vous allez la voir. Et la mononucléose infectieuse, c'est la maladie qui aura un polymorphisme clinique. Il peut avoir toutes les figures des angines.

(44:18 - 44:31)

Angine RND-12, angine RND-12 plus classée pour angine pseudochondralosie. Les trois. Alors la particularité de cette angine, c'est le terrain.

(44:31 - 44:48)

Il touche souvent l'adulte jeune avec des fosses membranes grisades et microtiques. Ce qui touche les amicales rouges hypertrophiées. Une altération importante de l'état général.

(44:49 - 44:59)

Une fièvre très élevée. Une asthémie importante. Des adénopathies sous-digastriques, c'est-à-dire jugulocarotidiennes hautes.

(44:59 - 45:10)

Un ratch putané. Qu'est-ce que c'est que le ratch putané ? Lorsque le patient se gratte, il y a des traces rouges qui se créent sur sa peau. Et une splénomégalie.

(45:10 - 45:24)

Vous voyez le tableau clinique qui est assez caractéristique. C'est un jeune en général de 20

ans, 18, 20 ans, 25 ans, 24 ans, qui est très malade. Altération de l'état général, fièvre élevée, asthémie, splénomégalie.

(45:24 - 45:37)

Bien sûr, il faut la chercher, ratch putané, mais qui fait des angines. On regarde son oropharynx, il y a ça. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire le MNI test.

(45:38 - 46:06)

Vous allez voir, le traitement repose sur un traitement symptomatique. Et bien sûr, je fais une numération en formule sanguine qui va me montrer une hyperlophocytose, mais c'est une hyperlophocytose particulière. D'ailleurs, c'est pour ça que le nom, c'est ça qui a permis de poser le nom de la mononucléose infectieuse, parce que l'hyperlophocytose est à basophiles.

(46:07 - 46:15)

Les basophiles sont comment ? Ils sont mononucléés. Ce ne sont pas les polynucléaires. Ils sont mononucléés.

(46:15 - 46:30)

C'est pour ça qu'on les appelle la mononucléose. Il y a des cellules mononucléosiques, mais qui sont d'origine infectieuse. Le traitement est symptomatique.

(46:31 - 46:46)

Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut mettre ? Un antalgique antipyrétique. Et bien sûr, les bêta-lactamines sont contre-indiqués. Pourquoi ? Parce qu'ils risquent de donner ce qu'on appelle un exantème important.

(46:47 - 47:01)

C'est quoi l'exantème important ? Vous connaissez l'exantème ? C'est comme des brûlures. Très importantes au niveau de la peau. C'est quelque chose qu'il faut éviter dans la prise en charge des patients.

(47:03 - 47:19)

C'est pour ça qu'on vous a dit, les angines érythémateuses et érythématopultacées, c'est le traitement antibiotique, mais les pseudomembraneuses, il faut réfléchir. On ne vous a pas dit antibiotiques, non ? Attention à l'écusserie. C'est ça l'écusserie.

(47:20 - 47:40)

D'accord ? Bien, en conclusion, c'est une pathologie fréquente, les angines aiguës. Leur tableau

clinique est diversifié. On vous enseigne, les angines aiguës, c'est pour retenir l'angine, c'est l'angine que vous allez rencontrer de façon très fréquente.

(47:41 - 48:23)

Pourquoi ? C'est pour que le traitement soit bien adapté. Pourquoi est-ce qu'on traite les angines ? C'est pour prévenir les complications, que ce soit les complications loco-régionales ou les complications générales. Est-ce que vous avez des questions sur le cours des angines aiguës ? Oui ? S'il y a une place pour la psychothérapie, dans quelles angines ? Non ? Pour diminuer l'influence.

(48:24 - 49:00)

À votre avis, qui est la personne qui peut répondre à votre angine ? Est-ce que je donne des corticoïdes ? C'est comme des ANS. Donc il ne faut pas donner des corticoïdes parce que vous n'êtes pas sûr du diagnostic. La mycdolectomie est indiquée chez tout le monde.

(49:01 - 49:23)

S'il y a l'indication de la mycdolectomie, il faut la faire. Quel est l'âge limite inférieur de la mycdolectomie ? L'âge supérieur, 101 ans, la mycdolectomie. Pas de problème.

(49:24 - 49:52)

Mais l'âge inférieur, 50 ans. À quoi servent les amygdales ? Pour répondre à cette question, il faut savoir c'est quoi les amygdales, à quoi elles servent, etc. Alors, c'est quoi les amygdales ? C'est un tissu lymphoïde.

(49:52 - 50:16)

Hein ? Il est là pour quelle raison ? C'est pour la reconnaissance de germes par l'enfant lors de son développement. C'est pour qu'elle connaît la possibilité d'avoir une mémoire immunitaire. C'est pour ça que la mygdale pharyngée est derrière les crosses nasales.

(50:17 - 50:28)

La mygdale palatine est à l'entrée de l'oropharynx. Et la mygdale basilinguale, c'est l'anneau de Valdez. C'est pour ça qu'elle est là.

(50:29 - 50:42)

C'est pour que tous les germes, parce que les germes vont pénétrer par où ? Par les yeux ? Par les oreilles ? Ils vont pénétrer soit par la respiration, soit par le manger. Il n'y a pas d'autre solution. Hein ? C'est pour les petits-enfants.

(50:43 - 50:57)

Et à ce moment-là, le tissu lymphoïde va permettre de prendre le germe. Il va le techniquer. Il va donner ça au système lymphoïde de l'organisme pour fabriquer des anticorps.

(50:58 - 51:19)

Et il va fabriquer des anticorps et garder la mémoire des anticorps. D'accord ? Et à quel moment les amygdales vont se reposer pour faire ce travail ? C'est l'âge de trois ans. Vers l'âge de trois ans, les amygdales vont être là.

(51:21 - 51:31)

Et ils vont de temps en temps être infectés. Mais leur rôle vraiment immunitaire va devenir très minime. Ça veut dire qu'on peut les enlever.

(51:31 - 51:49)

Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que souvent les parents, quand c'est l'annulation de l'amygdale, ils vont refuser de la faire par peur de mettre leurs enfants au risque d'être faibles sur le plan immunitaire. Il faut leur expliquer. Et pour expliquer, il faut avoir la science.

(51:49 - 52:18)

Il ne faut pas expliquer que le médecin est équivalent aux patients. Pour le bien du médecin, il y a un petit peu d'étudier, non ? Pour que l'étudiant vienne, pour qu'il soit armé de science, pour expliquer aux patients les choses qui lui sont bénéfiques. D'accord ? D'autres questions, oui ? Il y a un souci.

(52:19 - 52:33)

Souvent, ils font suite à des angines à répétition. Souvent. Mais parfois, il y a des petits enfants qui ont des amygdales hypertrophiées sans vraiment qu'ils entrent dans le chapitre angine à répétition.

(52:33 - 52:51)

Ils font quelques angines, mais ça se hypertrophie de façon importante. D'autres questions ? Les angines ? Bien, alors si vous n'avez pas de questions, on va voir les cas cliniques. Enfant de 6 ans, sans antécédent, qui présente depuis 24 mois.

(52:51 - 53:13)

Ça veut dire quoi, 24 mois ? Deux ans, des angines à répétition. Et qui consulte depuis l'apparition, l'apparition depuis 24 heures d'une dysphagie fébrile, avec une autalgie bilatérale,

sans autoré. Vous voyez que je ne vous ai pas mis autalgie réflexe.

(53:13 - 53:27)

Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle soit réflexe ? Autoscopie normale. L'examen clinique montre une autoscopie normale, donc c'est une autalgie réflexe. Une fièvre à 38,5 degrés.

(53:28 - 53:39)

Examen de l'oropharynx. C'est une angine comment ? Érythémateuse. Avec une inflammation qui déborde sur l'oropharynx.

(53:41 - 54:11)

Quelle est votre diagnostic ? C'est une angine érythémateuse. Quelle est votre prise en charge ? Vous cherchez les computations. Non ? Vous voyez ça ? Vous décrivez les endocrinologues.

(54:11 - 54:23)

Même s'il a une indication d'hospitalisation. Cherchez s'il a un trismus. Cherchez, vous appuyez sur la base de langue et voir s'il n'y a pas un bon point dans l'oropharynx.

(54:24 - 54:31)

C'est ce qu'on appelle la fièvre érythématisée. Cherchez les ordres de computation. Consultation cardiaque.

(54:32 - 54:50)

Est-ce que votre enfant n'urine pas de sang ? Cherchez les complications. Et bien entendu, si j'ai la possibilité de différencier angine virale et angine bactérienne, je le fais. Si je n'ai pas, je considère que c'est une angine stratococcique.

(54:51 - 55:00)

D'accord ? Je considère que c'est une angine stratococcique. Qu'est-ce que je fais ? Je donne un traitement antibiotique. Quel est l'antibiotique le plus utilisé ? C'est l'amoxicilline.

(55:01 - 55:09)

Quelle est la durée du traitement ? C'est 6 jours. Et l'arthrosologie, on va voir ça dans la psychothérapeutique. Et bien entendu, je surveille le patient.

(55:11 - 55:23)

Normalement, au bout de 4 jours, tout va rentrer dans l'ordre. Et bien entendu, je l'explique aux

parents. Même si tout rentre dans l'ordre au bout de 4 jours, il faut continuer 6 jours de traitement.

(55:24 - 55:48)

Parce que s'il ne continue pas les 6 jours de traitement, il se peut que le corps développe des anticorps. D'accord ? Là, c'est le petit patient qui a eu le temps, sans antécédent, 36 mois d'évolution d'angine à répétition, apparition d'un renflement au sommeil avec des épisodes apnées. Et voilà donc comment on se présente l'enfant avec les renflements.

(55:48 - 56:03)

On trouve des amygdales qui se touchent. Il y a une classification dans ça. Et bien entendu, dans cette situation-là, il faut expliquer aux parents quel est le risque de l'apnée de son enfant.

(56:08 - 56:52)

Pertention pulmonaire, l'insuffisance cardiaque, le diabète, beaucoup de choses. D'accord ? Échecs scolaires, tout, tout, tout. Vous pouvez le penser, des troubles endocriniens majeurs, etc.

En fonction du renflement et l'apnée de sommeil, ça veut dire l'arrêt respiratoire pendant le sommeil donne des complications majeures. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut enlever ces amygdales pour libérer la voie de passage de l'air et des aliments. Alors, c'est un autre enfant qui présente depuis 48 heures une dysphagie fibroïde compliquée d'un trismus.

(56:54 - 57:31)

Les parents, ils vous disent le traitement que nous leur avons pris à la pharmacie, malheureusement, on n'arrive plus à lui donner sa bouche. Pourquoi ? Parce que, un, il n'en parle plus comme avant, et deuxièmement, même sa bouche, on n'arrive plus à lui ouvrir pour lui mettre le traitement. Et quand on l'examine, on trouve ça.

À ce niveau-là, on est à 39 degrés. Nous ne sommes pas plus à 38 degrés, etc. Nous sommes dans une situation d'une collection abscessée au niveau de la région monoclonale et la paroi musculaire des parents.

(57:32 - 57:49)

Et bien entendu, vous comprenez très bien que le diagnostic est fait, c'est facile. Trismus, bandement du voile, c'est un patient qui a de la fièvre en plus, et dans les parents, ils vous disent qu'il a fait une injure. Donc vous, comme vous le connaissez très bien, c'est un traitement opératoire.

(57:50 - 59:50)

Quelle est votre attitude ? Hospitalisation, deux, réellement battre les bouts, trois, incision antidéothérapie parentérale, et, bien entendu, amygdalaectomie à programmer après rétablissement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions concernant les oncologies ? Je pense que c'est le dernier cours que j'ai avec vous, non ? On a fait l'année dernière ? L'année dernière, on n'a pas fait l'année dernière ? Parce que vous faites ça avec la hausse tout simplement ? Oui ou non ? D'accord.

Je pense que c'est le dernier. Je ne sais pas si c'est possible, mais je pense qu'il y a une différence entre un frangiphone et un frangiphone, c'est-à-dire un frangiphone qui est un frangiphone, c'est-à-dire un frangiphone qui est un frangiphone, c'est-à-dire un frangiphone qui est un frangiphone. Alors, dans la pharyngite, les amygdales sont normales, c'est l'inflammation de l'oropharynx, la paroi postérieure, le voile, les piliers de l'amygdale sont bonnes, ça c'est la pharyngite.

(59:50 - 59:55)

Les angines, c'est la dernière différence.